

Política y programa de seguridad del paciente

Programa | Alcance base: fisioterapia | Estado: propuesta para adopción

1. Objetivo y resultado esperado

Prevenir daño asociado a la atención mediante identificación, comunicación, control de infección, prevención de caídas, consentimiento y vigilancia de dispositivos.

2. Alcance y condiciones de uso

Servicio de fisioterapia según riesgos reales. La instancia de orientación puede ser el propio profesional independiente; no exigir por esta plantilla comité institucional a un consultorio unipersonal.

3. Responsabilidades por rol

Rol	Responsabilidad
Fisioterapeuta responsable	Valorar, individualizar, informar, vigilar y registrar.
Ejecutor según proceso	Aplicar la técnica o tarea para la que tiene competencia.
Verificador o titular	Comprobar recursos, evidencias y acciones de mejora.

4. Recursos y preparación

Mantener documento vigente, responsables reales, recursos de la actividad y soportes del emisor o fabricante pertinentes. Antes de ejecutar comprobar disponibilidad y seguridad; si falta un recurso crítico, controlar el riesgo y registrar suspensión o alternativa.

Secuencia operativa y decisiones

El orden se adapta al episodio sin omitir los controles de seguridad. Las técnicas y parámetros concretos se definen por competencia, evidencia y fabricante; no se completan con valores de ejemplo.

1. Adoptar compromiso de seguridad, aprendizaje y trato digno, sin sancionar el reporte de bu

Adoptar compromiso de seguridad, aprendizaje y trato digno, sin sancionar el reporte de buena fe. Definir responsable, canal de notificación y controles ante riesgos inmediatos.

2. Construir matriz de riesgos por recorrido: cita, ingreso, valoración, intervención, movili

Construir matriz de riesgos por recorrido: cita, ingreso, valoración, intervención, movilización, limpieza, documentación y egreso. Incluir caída, quemadura, descarga, error de identidad, contacto no consentido y demora de remisión.

3. Seleccionar barreras prácticas para cada riesgo: dos identificadores, prueba de equipo, re

Seleccionar barreras prácticas para cada riesgo: dos identificadores, prueba de equipo, revisión de piel, vigilancia, consentimiento, superficies seguras y registro de respuesta. No sustituir barreras por un cartel.

4. Formar al equipo y explicar al paciente cómo advertir dolor, mareo, irritación o desacuerd

Formar al equipo y explicar al paciente cómo advertir dolor, mareo, irritación o desacuerdo. Favorecer participación sin trasladarle la responsabilidad de detectar todos los errores.

5. Recibir incidentes y eventos, atender al afectado y preservar hechos

Recibir incidentes y eventos, atender al afectado y preservar hechos. Analizar causas de tarea, equipo, entorno, organización y comunicación, sin atribuir automáticamente el daño a una persona.

6. Medir indicadores y probar eficacia de acciones

Medir indicadores y probar eficacia de acciones. Revisar una muestra real de historias y sesiones con acceso legítimo; relacionar hallazgos con capacitación, dotación y cambios de proceso.

Control, frecuencia y corrección

5. Verificación de la ejecución

Revisión local mensual de eventos y trimestral de resultados.

Reporte oportuno, no punitivo.

Los indicadores no se completan con cifras inventadas.

Momento	Comprobación y conducta
Antes	Verificar alcance, recurso y condición de uso descritos. Resolver discrepancias antes de comenzar; documentar aplazamiento cuando no es seguro.
Durante	Seguir los pasos de este documento y registrar modificaciones, novedades y actuaciones reales. Detener ante los criterios de riesgo del proceso.
Después	Comprobar resultado, integridad, limpieza o continuidad según proceso. Vincular registro y autor, sin dar por cumplida una tarea no observada.
Ante hallazgo	Contener el riesgo, describir causa, asignar acción y comprobar eficacia. Mantener abierto el pendiente mientras no exista evidencia de cierre.

6. Registro, conservación y seguimiento

Utilizar la ficha o formato asociado y conservar fecha, episodio, ejecutor y soporte. Los registros clínicos se incorporan a la historia reservada; documentos laborales y administrativos tienen acceso según su finalidad. Reproducir páginas de registro cuando se necesita espacio, sin condensar la información clínica ni registrar valores supuestos.

7. Aplicación normativa específica

11.1.5 y 11.3.1.22-26: información documentada, prácticas seguras, recursos y formación. Limitar técnicas al portafolio y verificar condiciones reales.

8. Adopción y revisión

Completar responsables y condiciones de sede, leer referencias y manuales íntegros, validar el proceso y socializarlo. Registrar versión adoptada y autenticación; revisar ante cambio de norma, producto, equipo, técnica o hallazgo y en el ciclo local anual. Frecuencias y metas locales de esta edición no se presentan como exigencias legales universales.

Ficha de aplicación y referencias

Registro vacío para reproducir. Completar solo con hechos reales; identificar el documento o expediente al que pertenece. No incluye nombre, logo ni firmas preincorporadas.

Riesgo y proceso	
Peligro y consecuencia	
Frecuencia y severidad	
Barreras existentes	
Acción requerida	
Responsable	
Indicador y fuente	
Fecha de revisión	
Evento relacionado	
Eficacia	

Fuentes y límites

Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes; manual, criterios generales 11.1 y servicio de terapias 11.3.1. Resolución 2080 de 2026, artículo 1: revocatoria integral de 1732 de 2026; no se utiliza su manual como exigencia vigente.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

Prácticas seguras

Resolución 3100, 11.1.5: política, actividades, instancia proporcional, identificación, comunicación, infección, eventos y consentimiento, documentación y formación; aplicar los criterios pertinentes al servicio.

<https://www.minsalud.gov.co/salud/prestacion-servicios/Paginas/sistema-obligatorio-garantia-calidad.aspx>

Aprobó

Eliana Milena Pardo Ríos

TP 60576